

【일련번호 4】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 본원 원무과

【처 분 종 류】 개선

【제 목】 코로나19 기관미수금 관리 미흡

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

원무과는 진료·검사·입원 정보 등을 수집하여 기관청구의 진행 및 기관미수 발생 건 확인, 청구 누락·오류 점검, 재청구를 진행하고 있으며, 병원의 재무 건전성 확보, 청구 누락 방지 및 회계 투명성 유지를 목적으로 병원이 기관으로부터 받을 금액 중 아직 수납되지 않은 기관미수금을 관리하고 있다.

2. 관계 법령(판단기준)

우리병원「진료규정」 제66조(요금 수납) 제2항에 의거 우리병원의 각종요금은 수가규정의 정하는 바에 의해 수납하고 진료비지급 관련 기관으로부터 진료비를 징수하고 있다. 또한 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제65조(시·도가 부담할 경비) 내지 제68조(국가가 보조할 경비)에 의거 감염병 환자의 입원 시 치료, 조사, 진찰 등에 드는 경비를 국가와 시·도가 부담하도록 규정하고 있는 바, 의료기관은 진료 후 진료비 청구가 가능하다.

또한, 「복무규정」 제4조 제1항 1호에 따르면 “직원은 법령과 정관 및 제규정을 준수하여야 한다”고 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 원무과에서 수행하고 있는 기관미수 현황을 점검한 결과, 코로나19 감염병 대응 과정에서의 발생된 진료비, 검사비, 격리비, 백신 접종비 등 관련 비용을 국가 또는 지자체에서 부담 또는 지원했음에도 불구하고 기관미수금인 상태로 남아 있는 현황을 [표3] 과 같이 확인하였다.

[표3] 코로나19 미수금 발생 현황

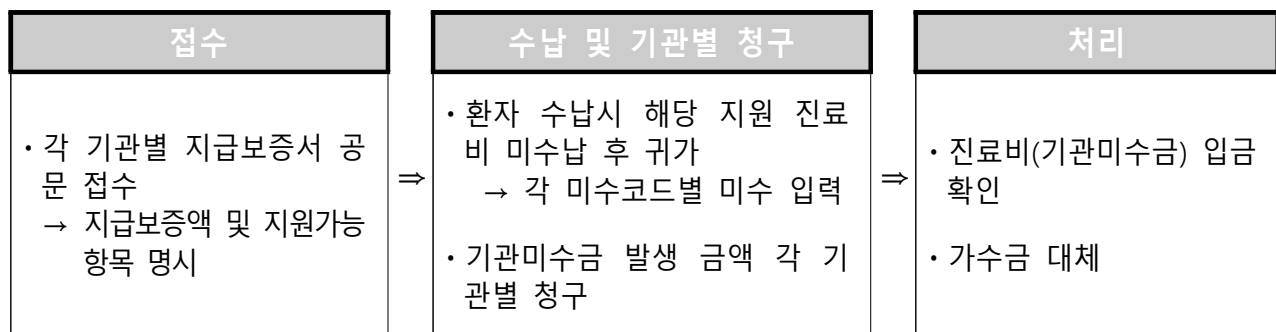
(단위 : 원)

구분		2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		총계	
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
외래	진단검사비					26	348,460	2	78,400			28	426,860
	소계					26	348,460	2	78,400			28	426,860
입원	격리입원 치료비 지원	18	1,185,110	9	300,630	84	1,556,020	12	51,880			123	3,033,640
	진단검사비			2	66,460	256	3,960,400	101	1,150,460	5	58,700	364	5,236,020
	코로나/독감 동시검사					7	170,200	13	163,450	4	122,220	24	455,870
	소계	18	1,185,110	11	367,090	347	5,686,620	126	1,365,790	9	180,920	511	8,785,530
총계		18	1,185,110	11	367,090	373	6,035,080	128	1,444,190	9	180,920	539	9,212,390

4. 판단요지

원무과는 「업무분장규정」 제27조에 따라 진료비미수금(보험청구분 포함)관리 및 징수총괄에 관한 업무를 소관하고 있으며, 기관미수금 발생 및 회수에 관하여 [그림1] 과 같이 처리하고 있다.

[그림1] 기관미수금 발생 시 업무 처리 흐름도



코로나19 감염병 국내 첫 확진자가 발생한 2020년 1월 이후 미증유의 상황에서 정부의 병원 지원 정책과 대응지침은 상황 변화에 따라 [붙임1] 과 같이 27회 이상 수시로 변경되었다. 이러한 혼란의 과정에서도 병원과 보건당국은 긴급 대응 체계를 구축 대응에 혼신의 노력을 기울여 전대미문의 위기를 극복할 수 있었다.

한편, 코로나19가 대규모로 유행하고 전국으로 확산되면서 우리병원은 선별 진료소 운영, 병상 확보, 음압병실 운용 확대 및 정부 및 지자체 지원금 청구, 감염병 대응 관련 보고체계 등을 마련하여 지역거점병원으로서 최선의 대응을 해왔지만 그 과정에서 코로나19 관련 진료비, 검사비, 격리치료비, 백신 접종비 청구 및 회계 처리, 정부·지자체 지원금 확인, 기관미수금 관리 등의 문제가 대두되었다.

이에 감사기간 동안 코로나19 발생이후 대응과정에서 진료·검사·격리치료 등으로 분류된 기관미수금(정부·지자체 지원금, 건강보험 청구 미완료 등) 관리 문제에 대해 살펴본 결과 **금9,212,390원의 미수금 잔액**을 확인하였다.

그 원인을 살펴보면, 공단이나 보건소 등에 청구한 사항이 수시로 변경되는 기준과 일치하지 않아 인정되지 않음으로써 처리 지연이 발생하였거나, 환자 부담금, 보험금, 정부 지원금이 혼재되어 분류 과정의 어려움이 발생하여 회계상 미수금으로 남게 되었음을 확인할 수 있었다.

원칙적으로 원무과는 기관미수금이 발생하면 청구 누락 여부를 확인하고 지원금 성격 및 법적 근거를 파악한 후 ①지원기간내에 청구하거나, ②지원기관으로부터 반려된 경우 보완 후 재청구, ③개인이 부담해야 할 진료비에 해당하는 경우는 환자 개인에게 진료비 금액, 기관부담에서 개인부담으로 전환 사유, 납부 방법 안내 등을 포함한 서면통지를 실시하고 개인미수금 계정으로 이관하여 회수한다.

따라서 기관미수담당자는 발생한 기관미수금을 적법·적정한 절차에 따라 적극적으로 회수함으로써 병원 재무 건전성을 확보할 책임이 있다.

즉, 기관 미수금 발생 건에 대한 청구 누락·지연 여부를 확인하고 관련 진료 기록, 지원금 신청 서류 등 회수 근거 자료를 확보하여야 하며, 정부·지자체, 보험 기관 등으로부터 발생된 미수금을 회수하기 위해 기관미수금 계정 정리, 미수금 상태를 모니터링하여 회수 현황, 미수금 발생 사유, 재청구 필요 여부 기록, 보고 및 개인미수금 전환을 통한 미수금 관리 업무를 성실히 수행하여야 한다.

그러나 코로나19 기관미수금의 경우는 청구 누락, 기준 변경 및 기준 미반영 등으로 장기 미수금이 발생하더라도 정부의 지원정책 변경 시점마다 지원금 청구 기준이 수시로 변경됨에 따라 긴박하고 혼란한 상황에서 기존 청구 내역도 변경사항을 반영하여 수정·재청구하는 것에 어려움이 있었음을 확인할 수 있었다. 또한 당시 인력부족 및 전산문제 등으로 원무과나 진료비심사과는 정부 지원금 변경 사항을 즉시 숙지하고 환자 상담 및 청구 업무에 반영하는 것에 어려움 또한 있었음을 이번 원무과 정기감사를 통해 인지하였다.

코로나19 관련 비용은 감염병 예방 및 관리에 따른 공적 부담금으로 환자 개인에게 부담을 전가할 수 없음이 원칙이며 「감염병예방법」, 질병관리청 지침, 건강보험 관련 규정에 따라 국가·지자체 지원금 우선 처리 의무가 존재하므로 환자 개인에게 부담지울순 없다.

설령 지원금 청구가 누락되어 환자에게 전환하려면 청구 근거와 증빙 자료가 필요하지만 감염병 대응 과정에서 기록 누락, 서류 불비 등으로 증빙 확보가 어려워 청구 근거가 불확실한 문제가 발생할 수 있다. 이와 더불어 장기 미수금 전환 시, 기존 정부·지자체 지원금 집행 내역과 중복 처리, 정산 오류 발생 가능성과 코로나19 치료·검사 등은 공적 의무성과 공익성을 가지므로 환자에게 개인 부담을 요구할 경우 민원 및 분쟁 가능 또한 예상할 수 있다.

따라서 진료비심사과 등 유관부서와 더불어 정부지원금 미수금, 건강보험공단 미수금에 대해 우선 코로나19 미수금 발생 과정을 진료 및 발생 단계, 청구 자료 입력 및 검증 단계, 심사·정산단계, 정부지원금 신청 단계 및 사후관리까지 일련의 **과정을 파악**한 후 회수가 가능한 부분과 회수가 불가능한 부분을 명확히 구분하여 코로나19 발생에 따른 **기관미수금의 조속한 정리**가 요구된다.

【처 분 요 구】

전남대학교병원장은 코로나19 기관미수금과 관련된 사항을 단계별로 점검하기 바라며 현재 남아 있는 미수금을 조속한 시일내로 정리하시기 바랍니다.
(개선-본원 원무과)

[붙임1]

코로나19 격리입원, PCR검사비 및 수가를 중심으로 한 정부 정책 변경 내역

시행년월	적용내역
2020.1.	· 신종감염병증후군(신종코로나바이러스 감염증) · 격리입원기간 환자부담(비급여포함) 국가지원 (1.28.) · DRG: 코로나 진료비 지원대상자(확진, 의사환자 및 조사대상 유증상자)가 질병군 발생 시 행위별 수가 적용 (1.29.) · 격리실 및 음압격리실 급여대상 확대(의사의 판단으로 감염이 의심되는 환자까지) (1.30.) · 상병 변경 (U18.1에서 임시 질병명 U07.1로 변경) (1.31)
2020.2.	· 코로나 19 진단 검사 신설(검사비용 환자부담금 지원, 100%는 제외)(2.7.) · 선별진료소 인플루엔자 검사 급여로 시행(JX999 선별진료소시행)(2.17.) · 선별진료소 응급의료관리료/ 격리관리료(응급) 산정 (2.18.) - 야간, 휴일에 내원한 코로나 19 확진·의사환자/ 격리 시행 시 · 코로나19 대응지침(6판)상 코로나19 관련 진단검사비 등 국비지원 (2.20.)
2020.3.	· 코로나19 대응지침(7판): 의사환자가 조사대상 유증상자로 변경적용 · 안심병원 지정 (3.9.) - 선별진료소 안심병원 감염예방관리료, 격리관리료 산정 · 코로나19 확진환자 격리 입원료 별도 보상(3.23.)
2020.4.	· 감염병전담병원 개산급(잠정지급) 형태로 손실보상금 지급
2020.5.	· 코로나19 검사 사회복지시설(노인, 장애인) 입소자 임상증상이 없이 1회 급여적용 (선별50%)
2020.7.	· 코로나19 응급용 선별검사시행 - 무증상 응급실 중증응급환자 또는 중증응급의심환자
2020.9.	· 코로나19 취합검사 신설 - 무증상 병원급 이상 신규 입원환자(선별50%)
2020.10.	· 코로나19 입원·격리 치료비 지원
2020.12.	· 코로나19 신속항원검사(선별50%), 코로나19확진 혈액투석 수가 신설
	· 코로나19 중증환자 전담치료병상 지정 관련 수가 신설(12.27.) - 전담 중환자실 입원료, 코로나19 중환자실내 음압격리관리료 - 기간: 12.18부터 소급적용
	· 코로나19 진단검사비 지원
2021.1.	· 코로나19 자가격리대상자 혈액투석 가산수가(OH020) 신설: 82,380원
	· 코로나19 거점전담병원 건강보험 수가 지원 확대, 병상 보상단가 10%인상
2021.4.	· 입원(소) 예정자 코로나19 확진검사(코로나 취합검사) 본인부담률 변경(선별 50% → 20%)
2021.5.	· 코로나19 대응 의료인력 감염관리 지원금 적용기준 및 청구방법 (5.11.) - 적용대상: 코로나19 확진에 따른 격리입원 치료환자 입원 1일당 1회 지원금 산정 - 적용기간: 2021.2.1.진료분부터 ~ 별도 종료 안내 시(재정소진)까지
2021.12.	· 코로나19 수술실 격리관리료 수가 신설 - 2시간 미만 수술(분만 포함): 307,130원 - 2시간 이상 수술(분만 포함): 511,890원
2022.2.	· 코로나19 경구치료제 투약 및 조제 관련 한시적 요양급여 (2022.1.4.~)
	· 코로나 취합검사 대상(보호자, 간병인, 실습생)의 급여확대 (2022.2.21.~) : 주1회

시행년월	적용내역
2022.3.	· 코로나19 분만격리관리료 한시적 적용(AH058, AH059) (기간: 2022.2.25.~ 4.30.)
	· 코로나19 확진분만(제왕절개)시 DRG적용
	· 코로나19 통합관리료 한시적적용 (2022.3.14.~ 3.31.)
	· 코로나19 입원·격리 치료비 지원
2022.4.	· 코로나19 안심병원 감염예방관리료(외래, 입원)수가종료 (2022.4.4.)
	· 코로나19 안심병원 선별진료소내 격리관리료(일반, 음압 격리관리료) 수가종료(2022.4.18.)
	· 코로나19 확진환자의 대면진료관리료 신설(외래 1일1회, 기간: 2022.4.4.~ 한시적 적용)
2022.5.	· 일반의료체계 전환에 따른 코로나19 관련 건강보험 수가 개편 - 코로나19 이행기(2022.4.25.~ 5.22.), 이행기 이후(2022.5.23.~) 코로나 가산수가 규모 축소 - 중증환자 전담치료병상 중환자실 내 음압격리관리료: - 통합격리관리료 변경
	· 코로나19중증, 준중증환자 전담치료병상 단계적 지정해제(2022.5.18.) - MICU2: 중증 전담치료 중환자실(코로나19)병실 구분 삭제 후 NCU1으로 복원 - 7-8, 4인실(7841~7844): 격리병실(54)→ 일반병실(00)으로 변경
	· 일반의료체계 전환에 따른 코로나19 관련 건강보험 수가 개편(5.20.) - 코로나19 야간간호료 종료(2022.5.23. 0시) - 이동형음압기 활용 시도 산정가능 코로나19확진 음압격리실 입원료 산정가능 - 코로나19 통합격리관리료 연장(~6.5.), 대면진료관리료 연장(~6.19.) - 코로나19 수술실격리관리료, 분만격리관리료, 혈액투석관리료 유지
	· 코로나19 격리관리료 수가 적용기준 변경 - 코로나19 통합격리관리료: 2022.6.6. 0시 종료 - 코로나19 통합격리관리료-중증 면역저하자 수가 신설 - 코로나19 다인실에서 1인격리 시 격리관리료 수가 신설 - 코로나19 다인실에서 2인격리 시 격리관리료 수가 신설
2022.6.	· 코로나19 격리관리료 수가 적용기준 변경 - 코로나19 통합격리관리료: 2022.6.6. 0시 종료 - 코로나19 통합격리관리료-중증 면역저하자 수가 신설 - 코로나19 다인실에서 1인격리 시 격리관리료 수가 신설 - 코로나19 다인실에서 2인격리 시 격리관리료 수가 신설
	· 코로나19 통합격리관리료(전담병상 제외) 한시 적용(기간: 2022.7.22.~ 2022.10.21.)
2022.7.	· 코로나19 입원·격리 치료비 지원
2022.8.	· 코로나19 관련 한시적 요양병원 감염예방관리 정책 가산료 수가 적용 및 청구
2022.9.	· 코로나-독감동시검사 수가(LSR00X02)
	· 건강보험적용 및 국비지원(2022.9.16.~)
	· 코로나19 확산세 감소에 따른 코로나19(중증, 준중증)지정병상 조정
2023.1.	· 코로나19 통합 격리관리료 수가 및 청구방법의 변경
2023.3.	· 코로나19 손실보상 기준 개정 - 개정내용사용병상 보상배수 하향 조정 - 병상 감축 시 병상 회전을 제고를 위해 준중증 병상 차등화
	· 코로나19 2급→4급 전염병으로 전환(2023.8.31.시행)
2023.8.	· 코로나19 검사 급여기준 변경
	· 코로나19 건강보험 수가의 연장 및 종료 - 격리실 입원료 산정방법 변경
2023.9.	· 코로나19 4급 전환에 따른 (신)포괄수가제 적용 및 청구 - 포괄수가제 대상 진료를 받은 환자가 국비지원 대상이 아닌 코로나19 관련 진료를 받은 경우, 「코로나19 건강보험 수가」는 적용 종료기간 전까지 포괄수가제 대상 진료내역과 분리 청구 - (포괄수가제 진료내역) 포괄수가제 / (코로나19 건강보험수가) 행위별수가제

시행년월	적용내역
2024.1.	· 코로나19 확진용 PCR 검사 재분류 - 국비지원대상 확대 - 건강보험 적용 대상 환자*의 보호자 · 간병인에 대해 선별50%적용(국비지원대상)
	· 위기단계 유지에 따른 코로나19 관련 건강보험 수가 연장 · 종료 안내 - 격리실입원료, 응급의료수가, 수술 · 분만 격리 관리료 수가, 확진환자 혈액투석 수 가,코로나19 진단검사 수가
2024.5.	· 코로나19 위기단계 경계→관심으로 하향(2024.5.1.) - 코로나19 격리입원 치료 지원 중단 - 진단검사비 국비 지원 종료(2024.5.1.) · 코로나19 치료제(벡클루리주, 팍스로비드,라게브리오) 투여시 환자 본인부담금 부과

※ 위 정부 정책 변경 사항은 감사기간 중 확인된 내역으로 더 발생했을 수 있음